

TEMA 1.2 • CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA

Fiebre Postquirúrgica

PERFIL EUNACOM 4.01.3.005

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción a Cirugía General

Las preguntas de cirugía general en el EUNACOM (aproximadamente 5 preguntas) suelen ser muy directas y sencillas. Incluyen temas como manejo de heridas, abscesos, hernias, uña encarnada, etc. **Importante:** Nunca preguntarán sobre técnica quirúrgica específica (ej. tipo de incisión). Lo que debes saber como médico general es identificar si la patología es de resolución quirúrgica o no.

Complicaciones Postquirúrgicas: Fiebre Postoperatoria

La fiebre en el postoperatorio es un signo clínico muy frecuente y su manejo se basa en identificar y tratar la causa subyacente. Las causas pueden ser graves (ej. TEP, infección) o menos graves. Para recordar las causas de fiebre postoperatoria, se utiliza clásicamente la mnemotecnía de las "W":

- **Wind (Respiratorio):** Neumonía, **Tromboembolismo Pulmonar** (TEP) y, más importante, **atelectasias**.
- **Water (Orina):** **Infección del Tracto Urinario** (ITU).
- **Wound (Herida):** Infección de la herida quirúrgica u otras complicaciones (dehiscencia de anastomosis, etc).
- **Wonderful Drugs (Fármacos):** Reacciones adversas a medicamentos (ej. Síndrome de Stevens-Johnson) y la hipertermia maligna.
- **Veins (Venas):** **Trombosis Venosa Profunda** (TVP), TEP, o tromboflebitis.

Cronología de la Fiebre Postoperatoria

TABLA 1.2.1: TIEMPO DE APARICIÓN VS CAUSA MÁS PROBABLE

TIEMPO DE APARICIÓN	CAUSA MÁS PROBABLE	RELEVANCIA CLÍNICA
Inmediata (durante o al salir de pabellón)	Hipertermia maligna	Fiebre muy alta (ej. 41°C). Secundario a reacción por anestésicos (ej. succinilcolina, gases halógenos). Urgencia médica.
Antes de 24 horas	Atelectasias	Es la causa de fiebre más frecuente en las primeras 24 horas. (Si no se describe eritema o pus en la herida, asume que es atelectasia).
Después de 48 horas	Infección de herida operatoria	Causa de fiebre postoperatoria más frecuente pasados 2-3 días.

1. **Examen físico:** Pulmonar, inspección directa de herida operatoria, revisión de vías venosas (D/C TVP), y control de orina.
2. **Estudio dirigido:** Radiografía de tórax, sedimento de orina y cultivo si se sospecha ITU, retiro de fármacos hipertermiantes.

Complicaciones Locales de la Herida Operatoria

Existen varias complicaciones locales que debes saber diferenciar con claridad. Aunque todas ocurren en la zona de la herida, tienen etiologías, clínicas y tratamientos radicalmente distintos:

1. Seroma

- **Clínica:** Edema localizado cerca de la herida. Aparece de forma muy precoz (aguda). Generalmente hay salida de líquido **serohemático** o linfático transparente, con dolor y equimosis. Secundario a sección de vasos linfáticos con inflamación de tejido celular subcutáneo. - **Diagnóstico:** Clínico. - **Tratamiento:** Medidas locales (curaciones) y estabilización con **drenaje aspirativo** (presión negativa) para evacuar el líquido progresivamente. Buen pronóstico.

2. Hematoma

- **Clínica:** Aumento de volumen de rápido crecimiento en la herida, secundario a una bolsa de sangre subcutánea. Suele acompañarse de mucho dolor. - **Diagnóstico:** Clínico. Ocasionalmente se utiliza ecografía en caso de dudas. - **Tratamiento:** **Drenaje quirúrgico precoz** (se debe abrir la herida, aspirar y lavar la zona).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

No drenar un hematoma quirúrgico de gran tamaño conlleva un altísimo riesgo de sobreinfección, transformando un cuadro netamente hemorrágico en un absceso grave.

3. Eventración (Hernia Incisional)

- **Clínica:** Debilidad persistente o rotura de las capas parietales que permite que las vísceras **protruyan** bajo un saco peritoneal íntegro. Ocurre característicamente meses o años después de la cirugía (ej. secundaria a cesárea antigua). Presenta masa reductible blanda y presencia de ruidos hidroaéreos en su interior. - **Diagnóstico:** Clínico. - **Tratamiento:** **Cirugía electiva** o programada (al igual que cualquier hernia no complicada). Si la hernia se comprime o se estrangula, operarla de urgencia.

4. Evisceración

- **Clínica:** Protrusión visible de las vísceras al exterior de la cavidad luego de una re-apertura dolorosa de la herida en el postoperatorio precoz o intrahospitalario. A diferencia de la eventración, **no existe saco peritoneal**, por lo que los órganos (las asas intestinales) están en posición externa. - **Diagnóstico:** Clínico radiante evidente. - **Tratamiento:** **Cirugía de urgencia** (reducción visceral a la cavidad, lavado y cierre estricto u otros manejos de abdomen abierto).

5. Dehiscencia de Anastomosis

- **Clínica:** El segmento del tubo digestivo operado presenta ruptura en su unión (filtración intestinal o gástrica interna). Se observa en el corto plazo postoperatorio manifestándose con signos de irritación peritoneal difusos y potentes: Blumberg (+), abdomen en tabla, ruidos hidroaéreos abolidos, y vómitos constantes. - **Diagnóstico:** Clínico. - **Tratamiento:** **Cirugía de extrema urgencia** para tratar la peritonitis y cerrar la filtración. Altísima mortalidad.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Pregunta clásica: Si te presentan paciente recién postoperado grave, febril, con "abdomen en tabla", "resistencia muscular" y silencio abdominal, el diagnóstico sugerido es una filtración (Dehiscencia de anastomosis intraabdominal).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un paciente de cuarenta y dos años es operado de colecistectomía laparoscópica. A las dos horas de terminar la cirugía, al salir de pabellón, presenta temperatura de cuarenta y uno grados Celsius, rigidez muscular generalizada y taquicardia. ¿Cuál es la causa más probable de esta fiebre?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Fiebre Postquirúrgica. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La nemotecnia para causas de fiebre postquirúrgica es Wind, Water, Wound, Wonderful drugs y Veins, cubriendo causas respiratorias, urinarias, de herida, farmacológicas y venosas.
- Las atelectasias son la causa más frecuente de fiebre postquirúrgica antes de las veinticuatro horas del postoperatorio.
- La infección de la herida operatoria es la causa más frecuente de fiebre después de las cuarenta y ocho horas postoperatorias.
- La hipertermia maligna es la causa más frecuente de fiebre inmediata al salir de pabellón y se asocia a succinilcolina y gases halogenados.
- El seroma se trata con drenaje aspirativo con presión negativa y tiene buen pronóstico.
- La eventración es sinónimo de hernia incisional, tiene saco peritoneal y se trata de forma quirúrgica electiva; la evisceración es aguda, sin saco, y es urgencia quirúrgica.
- La dehiscencia de anastomosis se presenta con signos peritoneales y requiere cirugía de urgencia por riesgo de peritonitis grave.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (FIEBRE POSTQUIRURGICA)**PREGUNTA 1**

Un paciente de cuarenta y dos años es operado de colecistectomía laparoscópica. A las dos horas de terminar la cirugía, al salir de pabellón, presenta temperatura de cuarenta y uno grados Celsius, rigidez muscular generalizada y taquicardia. ¿Cuál es la causa más probable de esta fiebre?

- A)** Atelectasia pulmonar
- B)** Infección de la herida operatoria
- C)** Hipertermia maligna
- D)** Infección urinaria
- E)** Tromboembolismo pulmonar

PREGUNTA 2

Una paciente de treinta y cinco años operada de apendicectomía hace una semana consulta por aumento de volumen en la herida operatoria, con edema y salida de líquido transparente. Al examen, la herida no presenta eritema ni pus y la temperatura es treinta y siete punto dos grados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y su tratamiento?

- A)** Infección de herida, tratamiento con antibióticos
- B)** Seroma, tratamiento con drenaje aspirativo
- C)** Hematoma, tratamiento con drenaje quirúrgico
- D)** Eventración, tratamiento quirúrgico electivo
- E)** Dehiscencia de anastomosis, cirugía de urgencia

PREGUNTA 3

Un paciente de cincuenta años operado de resección intestinal hace dos días presenta fiebre de treinta y ocho punto ocho grados, dolor abdominal difuso, abdomen en tabla y silencio abdominal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Antibióticos y observación hospitalaria
- B)** Ecografía abdominal y observación
- C)** Cirugía urgente por sospecha de dehiscencia de anastomosis
- D)** Drenaje percutáneo guiado por imagen
- E)** Laparoscopia diagnóstica electiva

RESUMEN: FIEBRE POSTQUIRURGICA

La fiebre postquirúrgica es una complicación frecuente y potencialmente grave que requiere identificar su causa para tratarla adecuadamente. Las causas se recuerdan con la nemotecnia en inglés: Wind (causas respiratorias: atelectasias, neumonía, TEP), Water (infección urinaria), Wound (infección de la herida operatoria y dehiscencia de anastomosis), Wonderful drugs (reacciones adversas a medicamentos e hipertermia maligna) y Veins (TVP, TEP, tromboflebitis). En cuanto al orden de frecuencia según el momento de presentación: las atelectasias son la causa más frecuente antes de las veinticuatro horas, la infección de la herida operatoria es la más frecuente después de las cuarenta y ocho horas, y la hipertermia maligna es la causa más frecuente de fiebre inmediata, es decir, al salir de pabellón. La hipertermia maligna se asocia al uso de succinilcolina o gases halogenados y es una emergencia que requiere reconocimiento urgente. Adicionalmente se deben conocer otras complicaciones de herida quirúrgica: seroma (líquido inflamatorio y linfático, tratamiento con drenaje aspirativo), hematoma (acumulación de sangre, tratamiento con drenaje quirúrgico), eventración o hernia incisional (protrusión tardía con saco peritoneal, tratamiento quirúrgico electivo), evisceración (protrusión aguda sin saco peritoneal, urgencia quirúrgica) y dehiscencia de anastomosis (fiebre más signos peritoneales, urgencia quirúrgica por riesgo de peritonitis).